

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE ASERTIVIDAD DE RATHUS (RAS)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación Cuantitativa de la Conducta Asertiva y Autoafirmación

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Asertividad de Rathus (RAS: 30 reactivos).
Nombre Original (Inglés)	<i>Rathus Assertiveness Schedule (RAS)</i>
Autor Original	Dr. Spencer A. Rathus (1973), Seton Hall University.
Publicación Primaria	<i>Behavior Therapy</i> , 4(3), 398-406. Elsevier / Academic Press.
Adaptaciones al Español	León & Reig (1991, España); Caballo (1993); Flores-Galaz (2004, México).
Eje Clínico y Constructo	Eje II: Procesos Psicológicos. Asertividad, Autoafirmación, Expresión de Sentimientos y TCC.
Tipo de Instrumento	Autoinforme conductual de 30 reactivos con escala Likert de 6 puntos bipolares (-3 a +3).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (desde 14 años). Población comunitaria y clínica ambulatoria.
Tiempo de Administración	6 a 10 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Uso científico clínico y académico bajo citación formal de la publicación original.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO CONDUCTUAL DE WOLPE Y RATHUS

La Escala de Asertividad de Rathus (RAS) constituye el instrumento pionero y estándar de oro internacional para la medición empírica de la **conducta asertiva**. Diseñada originalmente en el seno de la Terapia de Conducta de Joseph Wolpe (1958) y Arnold Lazarus (1966), la asertividad se conceptualiza como la capacidad del individuo para expresar con franqueza sus convicciones, sentimientos, desacuerdos y derechos legítimos en situaciones sociales sin experimentar una ansiedad visceral paralizante y sin transgredir agresivamente los derechos ajenos.

Rathus operacionalizó la asertividad como una disposición conductual que integra: (a) la capacidad para decir “no” y resistir la manipulación; (b) la iniciativa para iniciar contactos sociales y entablar conversaciones; (c) la habilidad para expresar discrepancias y desacuerdos ante figuras de autoridad; y (d) la soltura para manifestar afecto, elogios y peticiones directas.

Desde la perspectiva psicofisiológica de la **inhibición recíproca** de Wolpe, la emisión deliberada de respuestas asertivas inhibe de manera refleja los circuitos de ansiedad condicionados dependientes del sistema simpático y la amígdala basolateral, reforzando la sensación de autoeficacia y control cognitivo prefrontal.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS DIRECTOS E INVERSOS

Polaridad de Respuesta	Nº Ítems	Sentido Signo	Contenido Conductual Evaluado
1. Conductas Asertivas	13 ítems	Directos (+)	Expresión franca de quejas, firmeza ante injusticias y reclamos espontáneos (ítems 3, 6, 7, 8, 10, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29).
2. Conductas No Asertivas	17 ítems	Inversos (-)	Inhibición social, sumisión pasiva, miedo a ofender y timidez extrema (ítems 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Precisión psicométrica satisfactoria: coeficiente alfa de Cronbach de 0.77 a 0.86 en validaciones españolas y latinoamericanas (León & Reig, 1991; Flores-Galaz, 2004). Fiabilidad test-retest $r = 0.78$ a 0.83 a las 8 semanas de seguimiento.
Estructura Factorial	Aunque originalmente se concibió como una escala unidimensional de asertividad general, los análisis factoriales confirmatorios en muestras clínicas hispanas muestran que el factor general da cuenta del núcleo común, justificando la sumatoria total.
Validez Concurrente y Criterio	Correlación muy alta con escalas de asertividad conductual observada ($r = 0.76$) y con la Escala de Wolpe-Lazarus. Fuertes correlaciones inversas con timidez social, ansiedad fóbica social (LSAS, $r = -0.62$) y sintomatología depresiva.
Sensibilidad al Cambio Clínico	Estándar de oro indiscutible para verificar la eficacia de programas de Entrenamiento en Asertividad (EHS), registrando ganancias superiores a 1.2 desviaciones estándar en la puntuación neta tras el entrenamiento.
Invarianza Demográfica	En muestras comunitarias adultas, los varones tienden a puntuar ligeramente más alto en conductas asertivas de confrontación directa (+8 a +12), mientras las mujeres puntúan más alto en autoafirmación de afectos.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 30 ítems se responde en una escala bipolar de 6 niveles que carece de punto neutro (0):

- **Puntos de la Escala:** +3 = «Muy característico de mí», +2 = «Bastante característico», +1 = «Ligeramente característico», -1 = «Ligeramente poco característico», -2 = «Bastante poco característico», -3 = «Muy poco característico de mí».
- **Paso 1 (Inversión de Signo de los 17 Ítems No Asertivos):** En los reactivos **1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26 y 30**, multiplicar la respuesta por -1 (ej. un valor +3 se convierte en -3, y un valor -3 se convierte en +3).
- **Paso 2 (Suma Algebraica Total):** Se suman algebraicamente las puntuaciones de los 13 reactivos directos y los 17 reactivos con signo invertido.
- **Rango Teórico Global: -90 a +90 puntos.** Puntuaciones negativas elevadas reflejan marcada inhibición o sumisión pasiva; puntuaciones positivas elevadas indican firme asertividad.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PUNTOS DE CORTE (RATHUS, 1973)

Estratificación	Puntuación Total	Nivel de Asertividad	Conducta Asistencial Recomendada
Inhibición Severa	-90 a -21 puntos	Déficit asertivo grave (corte ≤ -20)	Sumisión extrema, incapacidad para fijar límites y alto resentimiento interno. EHS prioritario.
Inhibición Moderada	-20 a +10 puntos	Asertividad baja / Situacional	Dificultades asertivas ante situaciones de confrontación o figuras de autoridad. Psicoeducación.
Asertivo Adaptativo	+11 a +45 puntos	Buena autoafirmación social	Capacidad adecuada de comunicación directa, respetando derechos ajenos. Ajuste óptimo.
Muy Asertivo	+46 a +90 puntos	Alta firmeza / Muy directo	Expresión muy franca; vigilar no incurrir en brusquedad o estilos de dominancia agresiva.

PUNTO DE CORTE DE ALERTA CLÍNICA (PUNTUACIÓN ≤ -20):

Una puntuación neta inferior o igual a **-20 puntos** en la RAS define la presencia de un **patrón de inhibición social patológica**. El paciente suele experimentar frecuentes abusos en el entorno laboral o de pareja y somatizaciones recurrentes (cefaleas, colon irritable) fruto de la ira reprimida y la indefensión aprendida.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN ENTRENAMIENTO EN ASERTIVIDAD (TCC)

PROTOCOLO CLÍNICO BASADO EN EL RAS:

- **Paso 1 (Identificación de Derechos Asertivos Básicos):** Entregar la “Carta de Derechos Asertivos” de Smith/Alberti: derecho a cometer errores, derecho a cambiar de opinión, derecho a decir “no lo sé” y derecho a no justificarse.
- **Paso 2 (Técnicas Conductuales Específicas):** Entrenamiento en consulta mediante juego de roles: técnica del disco rayado (repetir el punto de vista con calma), banco de niebla (conceder terreno formal sin ceder en el fondo) y la técnica del acuerdo asertivo.
- **Paso 3 (Transferencia Conductual al Entorno Real):** Diseñar tareas graduadas de autoafirmación semanal (ej. devolver un café frío, solicitar cambio de turno de trabajo).
- **Paso 4 (Monitorización):** Un incremento de **≥ 30 puntos** en la escala algebraica del RAS tras 12 semanas consolida el estilo asertivo adaptativo.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN SUMISIÓN CRÓNICA Y MOLESTIAS PSICOSOMÁTICAS

Identificación: Varón de 32 años, farmacéutico, remitido por gastroenterología por síndrome de intestino irritable refractario. El paciente relata incapacidad absoluta para fijar límites a su socio laboral (“hago horas extras constantes para no discutir, aunque por dentro me carcome la rabia”).

Evaluación Inicial RAS (Línea Base): Puntuación Algebraica Total = **-52 puntos** (Rango de Inhibición Severa). Puntuaciones en reactivos clave: ítem 1 (“la gente se aprovecha de mí”) = +3 (invertido = -3); ítem 4 (“me cuesta decir no”) = +3 (invertido = -3); ítem 20 (“cuando me enoja, lo digo”) = -3.

Intervención Aplicada: 12 sesiones de Entrenamiento en Asertividad individual (TCC). Se practicó el control de la respiración para frenar el bloqueo somático, la desensibilización sistemática de la culpa ante el enfado ajeno y ensayos de confrontación serena con su socio.

Reevaluación a las 12 Semanas: Puntuación Total RAS ascendió a **+18 puntos** (+70 pts netos de ganancia, ingreso al Rango Asertivo Adaptativo). El paciente negoció exitosamente un nuevo acuerdo de turnos equitativos y las crisis intestinales remitieron de forma completa.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

RIESGO DE CONFUNDIR ASERCIÓN Y AGRESIÓN:

Puntuaciones superiores a +65 exigen evaluar que la conducta no vulnere los derechos del interlocutor. La asertividad no busca ganar una batalla ni humillar al otro, sino expresar con legitimidad y respeto el propio sentir.

EVALUACIÓN DEL RIESGO EN EL ENTORNO:

En contextos familiares de maltrato activo o tiranía laboral, indicar asertividad sin valorar el peligro de represalias violentas es negligente. Calibrar siempre el equilibrio de fuerzas antes de prescribir conductas de oposición directa.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Rathus, S. A. (1973). A 30-item schedule for assessing assertive behavior. *Behavior Therapy*, 4(3), 398-406.
2. León, J. M., & Reig, A. (1991). Propiedades psicométricas de la Escala de Asertividad de Rathus (RAS) en una muestra española. *Revista de Psicología de la Salud*, 3(1), 35-51.
3. Wolpe, J. (1958). *Psychotherapy by reciprocal inhibition*. Stanford University Press.
4. Caballo, V. E. (1993). *Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales*. Siglo XXI de España Editores.